



**ПО ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАПИСИ НА
ПРИЁМ К ВРАЧАМ
(ПО МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ЦПИИОИЗ МИНЗДРАВА РФ)
«СПБ ГБУЗ «ГП №27»**

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ А.А.КОМАНЕНКО



СПб ГБУЗ «ГП № 27»

**Детское поликлиническое отделение,
ул. Глинки, дом 8, литера А, год
постройки 1775г.**

**Количество прикрепленного
населения
10533**

**Отделение скорой медицинской
помощи,
ул. Витебская, дом 11-13, литера А, год
постройки 1960г**

**Поликлиническое отделение,
Вознесенский пр., дом 27, литера А, год
постройки 1860г**

**Количество прикрепленного
населения
67141**



СПб ГБУЗ «ГП № 27»



Доходный дом Ф.И. Ротина
(Вознесенская лечебница М.Я.
Ауслендера)



Вознесенский пр., 27
Красноградский пер., 3

Архитекторы: Витт фон В. В.
Шайб В. В.
Год постройки: 1854, 1899
Стиль: Модерн

Количество прикрепленного населения , человек	67141
---	-------

Мощность поликлиники в смену, посещений	1310
---	------

Мощность дневного стационара, коек	25
------------------------------------	----

Количество терапевтических участков	40
-------------------------------------	----

	Штаты	Занято	Укомплектованность
Врачи	107,75	92	87
Средний медицинский персонал	84,25	77	90
Немедицинский персонал	19,75	17	84



Перечень мероприятий, регламентирующий запись на приём к врачу

1. Установлены нормативы продолжительности приёма в соответствии с должностями

Утверждены нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в т. ч. с учетом захвата времени на оформление медицинской документации

Должность	Время приема	Повторный прием в связи с заболеванием	На визит с профилактической целью	На квартирный вызов	Приказ МЗ России
Врач терапевт участковый	15 мин	70- 80% -10,5 мин	60-70% - 10,5 мин	30 мин	От 02.06.2015 N 290 н
Врач общей практики (семейный врач)	18 мин	70- 80% -12,6 мин	60-70%- 12,6 мин	30 мин	
Врач –хирург	26 мин	60-70% -15,0 мин	60-70% -15,6	30 мин	От 06.08.2020 N 810 н
Врач –офтальмолог	14 мин	70-80%- 9,8	60-70% -9,8		От 02.06.2015 N 290 н
Врач-отоларинголог	16 мин	70-80% -11,2	60-70% - 11,2		



Перечень мероприятий, регламентирующий запись на приём к врачу

1. Установлены нормативы продолжительности приёма в соответствии с должностями

Утверждены нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в т. ч. с учетом захвата времени на оформление медицинской документации

Должность	Время приема	Повторный прием в связи с заболеванием	На визит с профилактической целью	На квартирный вызов	Приказ МЗ России
Врач –педиатр участковый	15 мин	70- 80% -10,5 мин	60-70% - 10,5 мин	30 мин	От 02.06.2015 N 290 н
Врач –акушер-гинеколог	22 мин	70- 80% -15,4 мин	60-70%- 13,2 мин		
Врач –хирург детский	26 мин	60-70% - 15,6мин	60-70% -15,6	30 мин	-
Врач – невролог	22 мин	70-80%- 15,4 мин	60-70% -15,4	30 мин	От 02.06.2015 N 290 н
Врач-инфекционист	20 мин	70-80% -14 мин	60-70% - 12 мин		От 06.08.2020 N 810 н



Перечень мероприятий, регламентирующий запись на приём к врачу

1. Установлены нормативы продолжительности приёма в соответствии с должностями

Утверждены нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в т. ч. с учетом захвата времени на оформление медицинской документации

Должность	Время приема	Повторный прием в связи с заболеванием	На визит с профилактической целью	На квартирный вызов	Приказ МЗ России
Врач –пульмонолог	26 мин	70- 80% -18,2 мин	60-70% - 15,6 мин		От 06.08.2020 N 810 н
Врач –кардиолог	24 мин	70- 80% -16,8 мин	60-70%- 14,4 мин		От 19.12.2016 N 973н
Врач –эндокринолог	19 мин	60-70% -13,3 мин	60-70% -11,4 мин		
Врач –уролог	26 мин	60-70% -15,6 мин	60-70% -15,6 мин	30 мин	От 06.08.2020 N 810 н
Врач-гериатр	45 мин	70-80% -31 мин	60-70% - 27 мин		От 05.12.2023 0 N 657 н



Перечень мероприятий, регламентирующий запись на приём к врачу

2. Назначен ответственный сотрудник за расписание

Функция администратора : внесение изменений в МИС при формировании расписания и актуализации на день, ежедневный контроль соответствия опубликованного расписания приема врачей в медицинской организации действительной ситуации, контроль ведения листа ожидания

Контроль за своевременностью формирования, актуализации, организацией работы с листом ожидания возложен на заведующего ВПО , а также заведующих структурными подразделениями

3. Определён порядок ведения расписания

3.1 Определено количество посещений на 1,0 ставку врача определенной специальности

Должност ь	Продолжит ельность рабочего времени на прием в час	Продолжит ельность рабочего времени на прием в мин	Норма времени на прием одного пациента				Количес тво слотов конкурент ных в день (> 60%)	Общая продолжител ьность конкурентн ых слотов в день. мин	Количе ство слотов неконк урентн ых слотов в день	Общая продолжительн ость неконкурентн ых слотов в день. мин
			Первичный прием в связи с заболевание м (90%) (ПП)	Первичн ый прием с профилак тической целью (ПРОФ)	Повторн ый прием	Посе щен ие на дому				
Врач –терапевт участковы й	36	432 мин (7,2 ч)	15 мин	10,5	12	30	18 (15 – ПП 3-ПРОФ)	259 (233 – ПП 26 –ПРОФ)	10	173



Перечень мероприятий, регламентирующий запись на приём к врачу

3. Определён порядок ведения расписания

3.1 Определено количество посещений на 1,0 ставку врача определенной специальности

Должность	Продолжительность рабочего времени на прием в час	Продолжительность рабочего времени на прием в мин	Норма времени на прием одного пациента				Количество слотов конкурентных в день (> 60%)	Общая продолжительность конкурентных слотов в день. мин	Количество слотов неконкурентных слотов в день	Общая продолжительность неконкурентных слотов в день. мин
			Первичный прием в связи с заболеваниями (90%) (ПП)	Первичный прием с профилактической целью (ПРОФ)	Повторный прием	Посещение на дому				
Врач –хирург	33	396 мин (6,6ч)	26 мин	15,6	15,0	30	11 (9 – ПП 2 - ПРОФ)	238 (213 – ПП 23 –ПРОФ)	8	158



Перечень мероприятий, регламентирующий запись на приём к врачу

3. Определён порядок ведения расписания

3.2 Определено количество посещений к врачам определенной специальности с учетом занимаемых ставок (1,0; 0,75; 0,5; 0,25)

3.3 Установлены типовых наборов слотов (сетка расписания) для одного врача определенной специальности на один день согласно занимаемой штатной единице

Должность	Количество слотов конкурентных в день (> 60%)	Общая продолжительность конкурентных слотов в день. мин	Количество слотов неконкурентных слотов в день	Общая продолжительность неконкурентных слотов в день. мин
Врач –терапевт участковый 1 ставка	18 15 – По заболеванию 3-ПРОФ)	259 15 – по заболеванию шаг 15 мин 3 – проф – шаг 10 мин	10	173 10 повторных – шаг 10 мин
Врач –хирург 1 ставка	11 (9 – По заболевания 2 -ПРОФ)	238 9 –по заболеванию шаг 26 мин 23 –ПРОФ – шаг 15 ,6 мин)	8	158 8 повторных – шаг 15 мин



Перечень мероприятий, регламентирующий запись на приём к врачу

3. Определён порядок ведения расписания

3.4 Формирование типового расписания на один месяц, состоящего из наборов слотов, с учетом специфики и режима работы медицинской организации и должности врача

3.5 Осуществление контроля за формированием и внесением расписания в МИС

Процедура автоматизирована через осуществление контроля параметров расписания в соответствии с типовым набором слотов (числом конкурентных и неконкурентных слотов), должностями , началом и окончанием рабочего времени



Перечень мероприятий, регламентирующий запись на приём к врачу

4. Определён перечень должностей для самостоятельной записи :

Через ЕПГУ – 8 должностей :

1. врач –терапевт участковый ,
2. врач –общей практики ,
3. врач –педиатр участковый ,
4. врач –отоларинголог ,
5. врач –офтальмолог
6. Врач- акушер-гинеколог
7. Врач-хирург
8. Врач- детский хирург

Дополнительно : с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг ,при личном обращении в регистратуру или с использованием инфомата

9. Врач –уролог
- 10.Врач –инфекционист
11. Врач –гериатр
12. Врач кабинета профилактики



Перечень мероприятий, регламентирующий запись на приём к врачу

5. Определён горизонт записи - период времени (количество дней), начиная с текущего дня, на который разрешена запись на прием к врачу, диагностическое исследование, лечебную процедуру- **14 дней**

Установлена глубина записи к участковым врачам – не менее, чем на 7 дней, к врачам-специалистам– на 14 дней

6. Установлено соотношение доли конкурентных/неконкурентных слотов

Типовой набор слотов : **не менее 60 %** слотов от общего количества слотов являются конкурентными.

Для этого сначала 60 % рабочего времени врача, затрачиваемого на прием, переводится в слоты (время делится на продолжительность одного приема), а затем в случае, если количественно доля конкурентных слотов составила менее 60 %, часть неконкурентных слотов переводится в конкурентные.

Таким образом, время врача, которое отводится на прием по конкурентным слотам может быть существенно больше, чем 60 %.

Должность	Общее количество слотов	Количество конкурентных слотов	%конкурентных слотов
Врач –терапевт участковый	28	18	70
Врач –хирург	19	11	60



Перечень мероприятий, регламентирующий запись на приём к врачу

7. Установлен типовой набор слотов для специальности

Должность	Общее количество слотов	Конкурентные слоты	Неконкурентные слоты
Врач –терапевт участковый	28	18 Из них 15 – по заболеванию 3 – профилактическая цель	10 – повторный прием
Врач –хирург	19	11 Из них 9 – по заболеванию 2 – профилактическая цель	8 – повторный прием

Установлено количество конкурентных слотов для врачей –терапевтов участковых, врачей общей практики – 70% (18 талонов)

количество конкурентных слотов для врачей –специалистов – 60% (11 талонов)

8. Определён порядок ведения листа ожидания

9. Определен порядок информирования пациентов за 24-48 ч до визита

Перед явкой пациента проводится информирование пациента администратором о времени записи в медицинскую организацию заблаговременно (24 - 48 часов до момента записи), при отсутствии ответа –
отправка SMS при наличии согласия пациента на SMS -информирование



Перечень мероприятий, регламентирующий запись на приём к врачу

10. Определены организационные решения по разделению потоков (кабинеты (отделения) неотложной помощи, профилактики, выдачи справок)

Перераспределены потоки пациентов с разными целями обращений между структурными подразделениями

В зависимости от цели обращения пациента в медицинскую организацию принято четыре основных организационных решения по распределению потоков пациентов, цель обращения которых может быть достигнута без привлечения врача-терапевта участкового

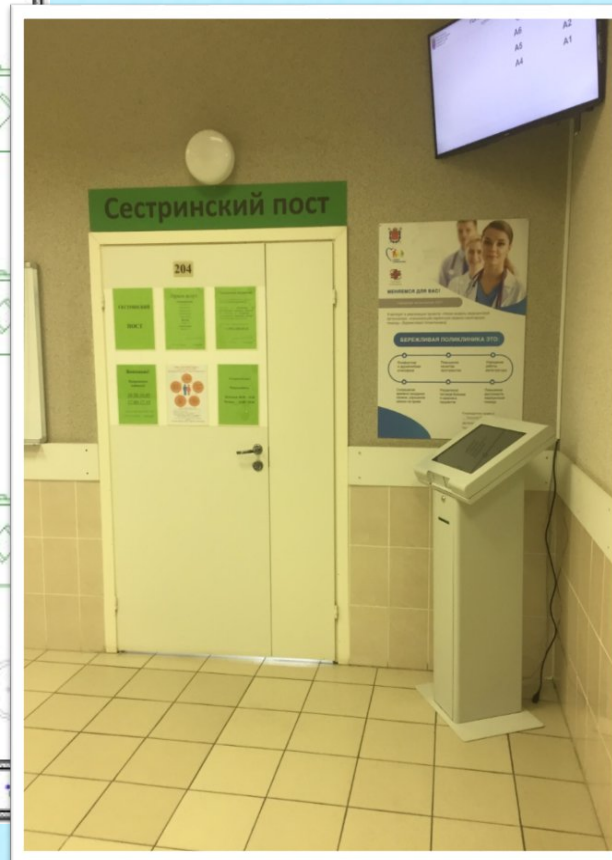
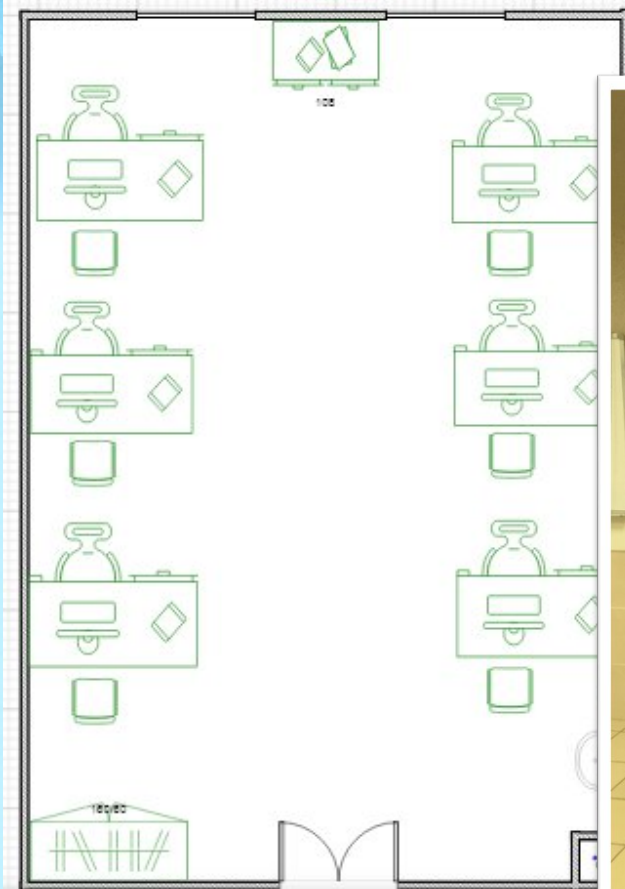
- перераспределение потока пациентов, обращающихся с очными запросами информации, в регистратуру медицинской организации с обработкой обращения
- перераспределение потока пациентов, нуждающихся в оказании помощи в неотложной форме, в отделение (кабинет) неотложной помощи при очном обращении;
- перераспределение потока пациентов, обращающихся с целью прохождения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и углубленной диспансеризации, в кабинет медицинской профилактики с организацией работы в соответствии с методическими рекомендациями ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России ;
- перераспределение потока пациентов льготной категории граждан

Информация размещена в Интернет-ресурсах на официальном сайте , на стендах в учреждении , дежурный администратор регулирует потоки пациентов



СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТОВ

2 МЕДИЦИНСКИХ





Анализ текущей ситуации по организации записи на приём к врачу

1. Количество дней до ближайшего талона записи на 01.09.2025

Должность	Количество дней до ближайшего талона записи
Врач терапевт участковый	0
Врач общей практики (семейный врач)	0
Врач –хирург	1
Врач –офтальмолог	1
Врач-отоларинголог	3
Врач- акушер- гинеколог	0
Врач-педиатр участковый	0
Врач-детский хирург	1



Анализ текущей ситуации по организации записи на приём к врачу

2. Анализ журнала отложенной записи на 01.09.2025

Специальность	Количество пациентов в Листе ожидания
Врач терапевт участковый	0
Врач общей практики (семейный врач)	0
Врач-педиатр участковый	0
Врачи- специалисты	0

В наличии свободные слоты в расписании для записи к врачам



Перечень мероприятий, регламентирующий запись на приём к врачу

12. Определён порядок перераспределения функций между врачами, медицинскими работниками со средним медицинским образованием и немедицинскими работниками

Диагностика заболеваний	Назначение лекарственных препаратов, медикаментозного лечения и лечебного питания	Оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной форме на дому	Назначение мероприятий по уходу за пациентом	Разработка программ оздоровительных мероприятий	Работа в составе врачебной комиссии	Оформление рецептурного бланка, санаторно-курортной карты, справок, направлений на МСЭ
Направление пациента к врачам-специалистам	Проведение экспертизы временной нетрудоспособности	Направление на медико-социальную экспертизу	Организация медицинской реабилитации	Проведение медицинских осмотров (профилактических, предварительных, периодических)	Диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями	Определение медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий (карантина)
Оценка эффективности и безопасности применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения	Предоставление отчетности о своей деятельности	Активное посещение маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения	Организация и проведение школ здоровья	Оформление листов нетрудоспособности	Оформление экстренного извещения при выявлении инфекционного заболевания, пищевом, остром профессиональном отравлении....	Контроль проведения профилактических мероприятий
Работа с медицинской документацией	Направление пациента на лабораторные и инструментальные обследования	Подготовка списков для диспансеризации населения	Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения	Ведение персонального учета, информационной (компьютерной) базы данных состояния здоровья обслуживаемого населения	Ведение паспорта врачебного (терапевтического) участка	Организация и проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ

- 11

функции врача – терапевта участкового
- 2

функции врача – терапевта участкового, переданные персоналу со средним медицинским образованием
- 12

функции, распределенные между врачом – терапевтом участковым и персоналом со средним медицинским образованием
- 2

функции врача – терапевта участкового, переданные персоналу без медицинского образования
- 1

функции, распределенные между врачом – терапевтом участковым, персоналом со средним медицинским образованием и персоналом без медицинского образования



Перечень мероприятий, регламентирующий запись на приём к врачу

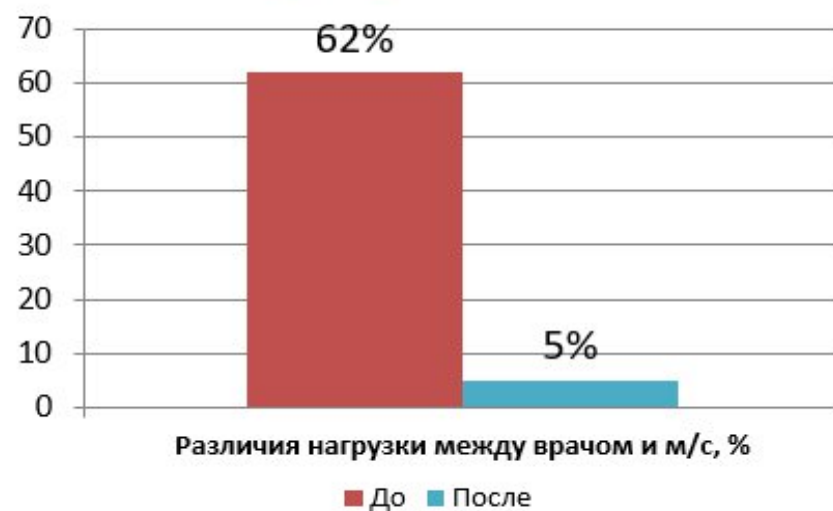
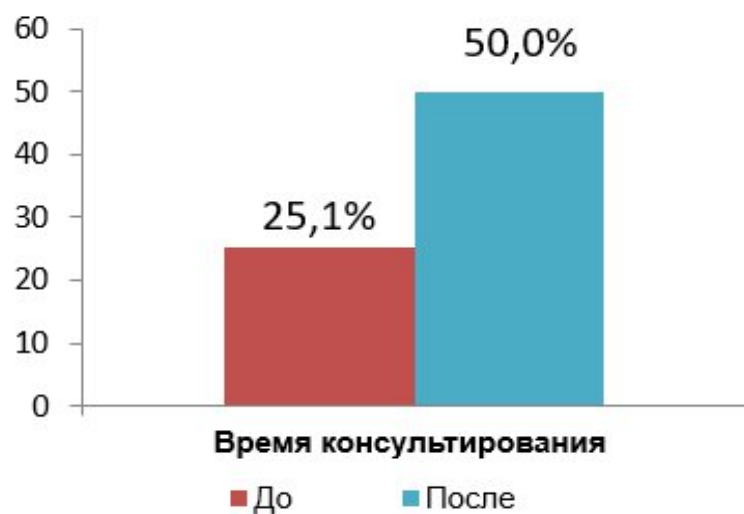
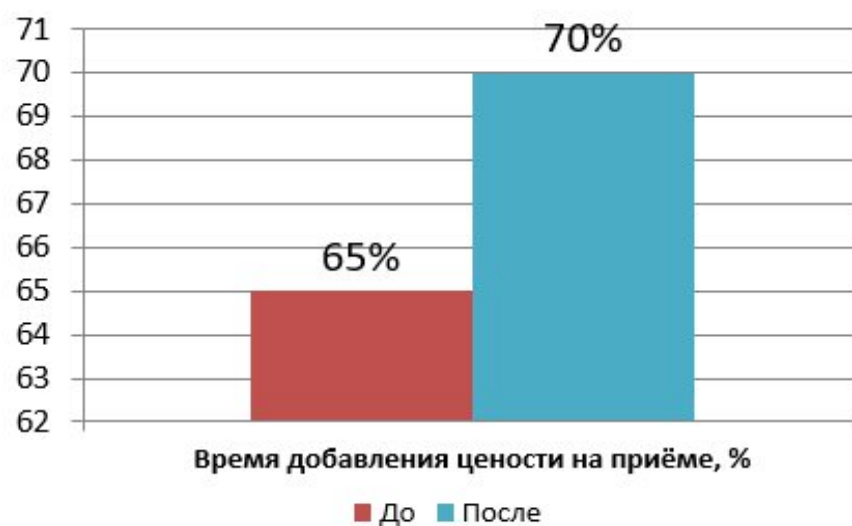
12. Определён порядок перераспределения функций между врачами, медицинскими работниками со средним медицинским образованием и немедицинскими работниками

Средний медицинский персонал

- формирование списков лиц для прохождения диспансеризации и диспансерного наблюдения
- формирование плана - графика пациентов для прохождения диспансерного наблюдения
- проактивное приглашение пациентов для прохождения профилактических мероприятий
- анкетирование пациентов в рамках прохождения диспансеризации с внесением данных в МИС
- формирование маршрута пациента по принципу «единого окна» на инструментальные и лабораторные исследования
- контроль выполнения лабораторных и инструментальных исследований в рамках ДН, явки на прием к врачу
- актуализация диспансерного наблюдения при впервые выявленных ХНИЗ
- посещение с целью динамического наблюдения и обследования маломобильных пациентов

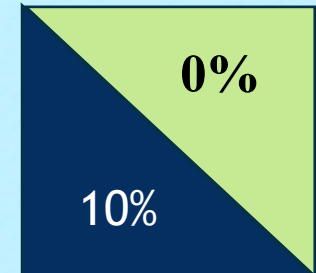
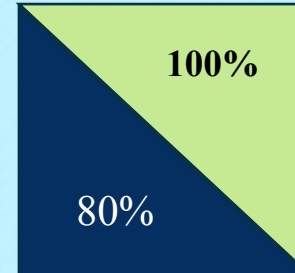
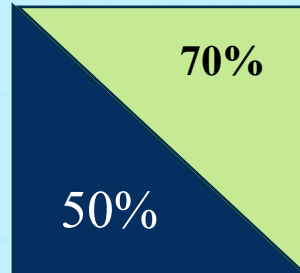
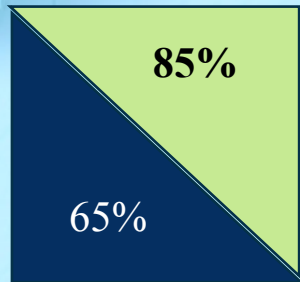
Немедицинский персонал

- ведение регистров пациентов с хроническими заболеваниями
- формирование списков лиц для прохождения диспансеризации и диспансерного наблюдения
- проактивное приглашение пациентов для прохождения профилактических мероприятий
- информационное сопровождение пациентов
- регистрация поступающих запросов и выдача документов





Результаты проведенных мероприятий

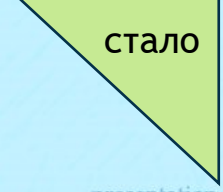
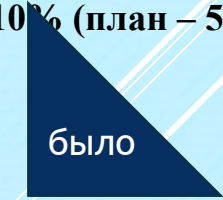
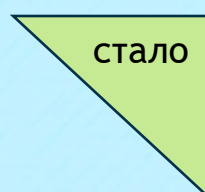
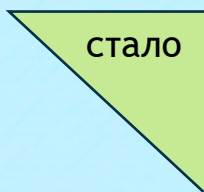
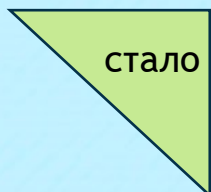
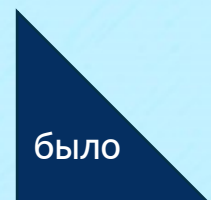


**Время
амбулаторного
приема**
Увеличено на 20%

**Количество слотов
записи**
Увеличено на 20%

**Доля успешных
записей на ЕПГУ**
на 20% (план 100)

**Доля
организационных
ошибок на ЕПГУ**
уменьшилась на
10% (план – 5%)





ПРОБЛЕМЫ. ПУТИ РЕШЕНИЯ

1. Пациенты, записавшиеся на свободный слот не являются на прием.

Предложение : обеспечить подтверждение записи на прием самим пациентом («обратная связь») через каналы, по которым произведена запись (ЕПГУ, Здоровье Петербуржца)

2. Трудность в планировании записи из –за невозможности спрогнозировать количество квартирных вызовов

Предложение : перераспределение квартирных вызовов на подразделения НМП

3. Перераспределение функций между врачами и медицинскими работниками со средним медицинским образованием для МО экономически невыгодно из-за отсутствия тарифа на услуги осмотра медицинским работником со средним медицинским образованием

Предложение : рассмотреть возможность формирования тарифа на оказание услуг средним медицинским персоналом



Спасибо за внимание!

**С УВАЖЕНИЕМ,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ А. А. КОМАНЕНКО**